



FICHA DE INGRESO PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL

Conforme a normativa chilena – Uso Clínico

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

- Nombre: Vicente Daniel Espinoza Ferretto
- RUN: 23.849.031-6
- Fecha de nacimiento: 07-01-2012
- Edad: 14 años 5 meses
- Sexo: masculino
- Escolaridad: 8°
- Establecimiento educacional: Colegio Carmen Teresiana de La Reina
- Nombre del cuidador/tutor legal: madre Eliana Ferretto
- Contacto:

2. MOTIVO DE CONSULTA

- Descripción del motivo de consulta: evaluar continuidad y dosis de tratamiento farmacológico actual
- Tiempo de evolución: Vicente presenta diagnóstico de TEA desde los 3 años, en tratamiento con sertralina y risperidona, esta última desde los 3 años, sertralina desde agosto 2025 iniciada por neurología debido a síntomas del ánimo secundarios a episodios de bullying. Madre plantea 2 problemáticas principalmente relacionados a funcionamiento a nivel escolar. La primera, es que ha detectado situaciones de parte de docentes en donde no se entregan los apoyos necesarios acorde a su diagnóstico. Ocurrió situación en donde se le solicita “pegamento”, no de manera clara respecto al tipo, y se le pone una mala nota por no llevar el tipo de pegamento específico. Frente a esto Vicente se angustia, queda “pegado” en este estado emocional bastante tiempo, se labiliza, tiende a reacción internalizante, no se desregula de manera externalizante ni en colegio ni en casa. Madre ha observado otras situaciones similares en donde ella ha solicitado mayores apoyos, pero colegio responde de manera parcial. Por otra parte Vicente inicia sertralina el año 2025 debido a episodios de bullying escolar en donde inicia síntomas del ánimo, angustia, bajo ánimo. Vicente tiende a no comunicar a madre acerca de estos episodios, ya que muchas veces él no logra ver mala intención en los agresores, debido a dificultad en entender códigos sociales. Pero si madre se ha enterado de niños de otros cursos que van a hacerle ruidos en los oídos dirigiéndose con mala intención, sabiendo que a este le molestan. Además, debido a entrada en adolescencia, este año ha sido más difícil porque ha sido dejado de ser invitado a

eventos sociales, cumpleaños, etc, debido a que compañeros presentan otros intereses, Vicente es mas pueril, existe poca inclusión de parte de pares también. Madre menciona que en colegio existe alumno con enfermedad de Duchenne a quien también hacen bullying y colegio es muy pasivo en sus intervenciones.

- A entrevista a solas con Vicente: cooperador, se observa buen animo. Se indaga en animo y ganas de vivir, refiere buen animo, no mucho entusiasmo por ir al colegio pero tampoco rechazo escolar, menciona al inicio de entrevista que compañeros de otros cursos lo molestan. Niega ideación suicida actual ni en alguna vez en su vida, niega ideas de autodaño. Se indaga en lo que mas le guta hacer en la vida: "estar con mi familia", ver tele. Se pregunta dirigidamente por algún miedo, preocupación, algo que lo mantenga nervioso o preocupado, niega. Refiere afecto, cariño y protección de parte de su familia.
- Se hace entrega a madre de que actualmente no impresiona un animo deprimido, factor protectos importante es la familia. De necesidad de mantener sertralina ya que el probable que se mantengan dificultades a nivel social, mantener peers, bajar risperidona a 4 gotas, posible traslape a azymol. Se realizará informe escolar para concientizar a colegio sobre daño que estaría generando episodios de bullying.

3. ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS PERSONALES

- Diagnósticos previos: TEA diagnóstico realizado a los 3 años por neurólogo
- Hospitalizaciones previas: no
- Tratamientos farmacológicos: risperidona 6 gotas por noche (llegó a dosis máxima 10 gotas por noche), sertralina 50 mg ½-0-0 desde agosto 2025 indicado por neuróloga. Se suspende risperidona y aparecen tics en boca, movimientos cuello. Toma además melatonina en gotas para conciliar sueño.
- Psicoterapia previa: si, con psicóloga, TO, apoyo de fonoaudióloga desde los 3 años, y actualmente asistiendo a PEERS
- Conductas autolesivas / ideación suicida: NO Y NO

4. ANTECEDENTES MÉDICOS GENERALES

- Patologías médicas relevantes: sano, antecedente de TEC con hematoma subdural operado a los 5 años, al parecer sin secuelas. Hipoplasia Hipofisaria en controles con endocrinólogo recibiendo hormona del crecimiento actualmente.
- Tratamientos actuales: hormona del crecimiento
- Alergias: no reportadas
- RAM: emesis con azymol

5. ANTECEDENTES FAMILIARES

- Antecedentes psiquiátricos familiares: no
- Contexto psicosocial relevante: Vicente vive junto a ambos padres y su hermana de 11 años, ambiente armónico en casa, no aparecen indicadores de disfuncionalidad a nivel familiar.

6. EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL

- Apariencia: constitución mesomorfa a endomorfa, se observa menor a edad cronológica, vestimenta e higiene adecuada
- Actitud:cooperador, pueril
- Psicomotricidad: se observa normal
- Lenguaje: Notificativo, atingente, sin alteraciones en estructura.
- Pensamiento: Sin alteraciones formales, niega delirios y niega alteraciones sensoriales hoy. Contenido en relación a dificultades sociales y de comunicación en colegio.
- Ánimo impresiona eutímico
- Contacto visual adecuado
- Juicio de realidad: conservado, no psicótico.
- Insight: no evaluable

7. EVALUACIÓN DE RIESGO

- Riesgo suicida: no
- Factores de riesgo: neuro divergencia, dificultades en pragmática del lenguaje, dificultades para leer códigos sociales presente, riesgo bullying, intereses no típicos con respecto a pares de su edad, bullying presente, riesgo de trastorno del ánimo. Riesgo de adicción a pantallas.
- Factores protectores: buen nivel cognitivo, familia responsiva y afectiva con buen nivel cognitivo, madre con buena capacidad de mentalización, comprende dificultades de su TEA, momentos en familia, capacidad económica para terapia sin interrupciones.

8. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA (DSM-5 / CIE-11)

- Diagnóstico principal: TEA
- Diagnósticos secundarios:bullying escolar

9. PLAN TERAPÉUTICO

- Tratamiento farmacológico: sertralina 50 mg mantener ½- 0 -0 durante periodo escolar, risperidona 1mg/ml bajar a 4 gotas y observar respuesta. (si no hay buena respuesta se intentará traslape a azymol jarabe).
- Intervenciones psicosociales: familia con historial de intervenciones, madre sabe leer de manera adecuada a Vicente, se psicoeduca con respecto a fármacos, su rol, sus posibles RAM.
- Derivaciones: mantener PEERS
- Se realiza informe para colegio para mayor monitoreo y supervisión bullying y para mejorar estrategias de comunicación (lenguaje oral escrito de manera mas concreta).

10. SEGUIMIENTO

- Fecha próximo control: 1 mes posterior al control(evaluar traslape a azymol)
- Red de apoyo: padres
- Indicaciones a cuidadores:

11. DATOS DEL PROFESIONAL

Nombre: Caterina Schiappacasse Arteaga

Especialidad:psiquiatra infanto juvenil

Registro profesional:105595

Centro de atención: Psicoeduka Santiago

Fecha: 10 de junio de 2026